

08 - 3-examen du Rachis sono maker

(0:01 - 0:23)

C'est quoi la particularité du rachisme ? Les postures, ça veut dire les postures. Plutôt, mais c'est une posture. Il est corrompu, il est paisible, il est corrompu.

(0:25 - 0:40)

C'est un vital, qu'est-ce qu'on a pour un vital ? Une psychose, une psychose. Une lordo, cervical. Très bien, elles ont un lordo cervical.

(0:41 - 1:01)

Dorsal via, petite psychose et la lordose. Quelle est la particularité du rachisme ? Le livre agit, ça veut dire. Système nerveux central.

(1:02 - 1:14)

Vous vous approchez, c'est ça. Alors la particularité du rachisme, c'est l'atteinte nerveuse. L'atteinte nerveuse.

(1:14 - 1:24)

Plus la racine. Parce que vous pouvez avoir des atteintes et au moins superficielles. Les lèvres superficielles.

(1:24 - 1:42)

Mais là, si on a une attention au rachisme, ça va être au niveau de la racine. Est-ce que vous connaissez un exemple de névragie ? Névragie, c'est la douleur liée au nerf. Hernie discale.

(1:42 - 1:59)

Hernie discale, c'est l'étiologie. Le nerf sciatique, on l'appelle la sciatique. Si j'ai une hernie discale au niveau du rachisme cervical, je vais avoir quoi ? Des douleurs.

(2:00 - 2:08)

Le ventre supérieur, on appelle ça névragie. Névragie, toujours, c'est la douleur liée au nerf. Cervical.

(2:09 - 2:16)

Cervical, il prend l'essence au niveau du rachisme cervical. Brachial. Névragie cervical, brachial.

(2:16 - 2:21)

Et irradiement du bras. D'accord ? Très bien. On commence.

(2:30 - 2:37)

Petit rappel. Le rachisme est constitué de trois segments. Le rachisme cervical avec 5 vertèbres.

(2:38 - 2:47)

Dorsal ou thoracique, 12 vertèbres. Et le lombaire avec 5 vertèbres. Les trois segments sont reliés par des charnières.

(2:47 - 3:03)

Et il y a un agencement qui confère au rachisme une grande mobilité. Vous reconnaissez ici ? Une vertèbre. D'accord ? Ça c'est ? Le corps vertébral.

(3:03 - 3:20)

D'accord ? On appelle ça le mur antérieur. Il est constitué par le corps vertébral et le disque intervertébral. Le mur postérieur est constitué par quoi ? Les lames.

(3:22 - 3:38)

Les ? Ça c'est ? Les apophyses postérieures. Les apophyses articulaires postérieures qui font, celle d'en bas et celle d'en haut, font une articulation. On appelle ça l'articulation des apophyses postérieures.

(3:39 - 3:59)

D'accord ? Il y a les épineux et il y a ce trou de conjugaison. Alors, au niveau du talon vertébral, il y a la moine entourée du mur vert. Et, de part et d'autre, vont partir les racines nerveuses.

(4:00 - 4:16)

D'accord ? Les racines nerveuses sortent où ? Elles ne sortent plus du trou de conjugaison. D'accord ? Et là, il y a un ganglion qui est hyper agile. Donc, s'il y a un ganglion, la douleur est très intense.

(4:17 - 4:29)

Elles vont se diviser en deux petites racines. La racine postérieure qui va en postérieure, elle est motrice. Et celle en dernière, sensitive.

(4:31 - 4:43)

Et cette racine, elle va passer à côté du disque intervertébral. Alors, dedans, on comprend. Votre camarade a parlé tout à l'heure de l'écrasement.

(4:43 - 4:53)

C'est quoi l'écrasement distincte ? C'est ? C'est l'atteinte d'une âme. D'écrasement ? D'une âme. Plutôt ? Ce n'est pas un écrasement.

(4:53 - 5:02)

C'est plutôt ? Épanchement. C'est l'épanchement. Disparaître ? Rupture du disque.

(5:02 - 5:16)

Rupture du disque. Alors, finalement, le disque, il est fait comment ? Il a un nanofibreux périphérique. Mais à l'intérieur, le disque où il est, il est plus peu.

(5:16 - 5:27)

D'accord ? C'est l'intérieur du disque qui va sortir. Il va faire écrasement. D'accord ? Ce n'est pas un choc.

(5:27 - 5:33)

Le rachis cervical, c'est soit un frein. C'est le cou de lapin. Soit un arrêt.

(5:33 - 5:50)

D'accord ? Il faut que ça soit très violent pour que j'ai une écrasement. Surtout le jeune âge. Après, quand on est grand, c'est là où il va y avoir la sécheresse de ce disque.

(5:50 - 6:07)

Parce qu'il est très très hydraté quand on est petit, quand on est jeune. Et il va, au fil des années, il va s'assécher. D'accord ? Et ça va être plus facile, vers l'âge de 40-50 ans, d'avoir une écrasement disque.

(6:08 - 6:18)

Ce n'est pas comme chez le jeune. D'accord ? Vous imaginez, si j'ai une écrasement ici, il va y avoir le conflit avec le rachis. Pareil.

(6:19 - 6:38)

Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est une articulation ? C'est là où je peux avoir les signes de l'arthrose. Ce disque, ce trou de conjugaison, si j'ai une arthrose, il va y avoir... Vous vous

rappelez, il y a les signes. Qu'est-ce qu'il va y avoir de l'arthrose ? La condensation.

(6:40 - 6:46)

Les surfaces, elles vont s'agrandir. Il va y avoir une condensation. Et les ostéophytes.

(6:46 - 6:59)

Les ostéophytes, c'est comme les épines. Des fleurs. Vous imaginez la racine qui était très... C'est-à-dire, l'espace était très spacieux.

(7:00 - 7:13)

Il va se retrouver à l'étroite. D'accord ? Et ça, c'est les écologies qui peuvent causer une émerge. D'accord ? Les trous de conjugaison sont en latéral.

(7:13 - 7:27)

De part et d'autre. C'est pourquoi qu'au cours de la préparation, pratiquement tous les étudiants font des positions prononcées. D'accord ? Ils ne maintiennent pas leur position dans l'évidence normale.

(7:28 - 7:36)

Ils vont avoir toujours mal au niveau du rachis. Ils peuvent avoir mal au niveau des doigts. Des bras.

(7:37 - 7:54)

D'accord ? Alors... La douleur au niveau du rachis s'appelle... Rachiandi. Rachis cervical. On parle de... Cervicalgi.

(7:55 - 8:01)

Dorsal. Dorsalgi. Et lombargi au niveau du rachis lombaire.

(8:02 - 8:25)

Quand j'ai une douleur du rachis avec une atteinte radiculaire... Radiculaire, c'est par rapport à la racine du nerf. D'accord ? Je parle du névralgi. D'accord ? Alors... Le névralgi qui est le rachis... Au niveau du rachis cervical, c'est le névralgi cervical... Brachial.

(8:25 - 8:36)

Brachial. Je... Elle prend naissance... Je peux avoir un corticole au matin. D'accord ? Puis après, je vais sentir... Découvrir un joint.

(8:37 - 8:44)

Je vais sentir un muscle qui est contracté. Une douleur. D'accord ? Ça vient tout doucement.

(8:44 - 8:54)

Là, ça va venir. D'accord ? Le rachis dorsal. On appelle ça le névralgi intercostal.

(8:55 - 9:08)

Pourquoi intercostal ? Parce qu'il s'en sentit en hémiceinture. On l'a en ceinture. Soit quelque chose... Il n'y a rien.

(9:09 - 9:17)

Je gratte. Soit un fourmillement, soit une douleur. C'est une douleur qui suit en hémiceinture.

(9:18 - 9:27)

Là, je peux la sentir. C'est vraiment ça. D'accord ? Ça, c'est le névralgi intercostal.

(9:28 - 9:35)

Au niveau du rachis cervical, il y a deux. Il y a la lampe siatique. Siatique.

(9:35 - 9:43)

Il est lié à l'atteinte du racisme constituant du nerf siatique. Il y a deux. Il y a S1.

(9:43 - 9:51)

Il y a S2. Il n'y a pas d'autre. Lampe siatique, c'est en postérieur.

(9:51 - 10:01)

En postéro-externe. On va voir ça. Et il y a en antérieur, par rapport à l'atteinte du nerf crural, ce qu'on appelle lampe crurale.

(10:01 - 10:11)

D'accord ? Lampe crurale dit pardon. C'est soit par l'atteinte de la L4, soit par l'atteinte de la L3. C'est bon ? On répète.

(10:13 - 10:19)

Là, douleur au niveau du rachis cervical. Cervicalgi. Dorsal.

(10:20 - 10:22)

Dorsalgi. Lampe. Lampe.

(10:22 - 10:34)

Dorsalgi. Quand on a une atteinte radiculaire, qu'on appelle ça névralgi, au niveau du rachis cervical, on a la névralgi. Cervicobrachial.

(10:34 - 10:39)

Au niveau du dorsal. Névralgi intercostal. Et au niveau lampe.

(10:40 - 10:43)

Lampe siatique. Lampe siatique. S1.

(10:44 - 10:47)

L5. Lampe crural. Lampe cruralgi.

(10:48 - 10:58)

L3. L4. Alors, vous devez faire part entre siatique et lombo-siatique.

(10:58 - 11:21)

On n'utilise pas toujours lombo-siatique. Qui peut me dire dans quelle situation on peut parler de lombo-siatique ? Si c'est possible. D'accord ? Ça veut dire lombo, c'est par rapport à la non-balgie.

(11:21 - 11:34)

C'est-à-dire qu'une patiente, il a au même temps la douleur au niveau de son rachis et la douleur qui descend. Parfois, il voulait qu'elle parvenisse à ça. Parfois, il voulait qu'elle parvenisse à ça.

(11:34 - 11:47)

D'accord ? Vous allez entendre ça. Je vous dis ça au naval, comme ça vous allez vous familier. Et peut-être donner des tests spécifiques avant de voir.

(11:50 - 12:04)

Bien. Alors, lombo-siatique, lombo-cruralgi, c'est quand on a une participation du rachis lombaire. Si j'ai juste la siétagie, je vais dire siétagie.

(12:06 - 12:13)

C'est bon ? Très bien. La douleur. On revient à la douleur.

(12:17 - 12:35)

Est-ce que c'est important ? Tout à l'heure, l'épaule, nous n'avons pas insisté sur la douleur inflammatoire, la douleur mécanique. Pourquoi ? Parce que nous notons que dans 95% des cas, c'est une tendinopathie jusqu'à près du contraire. Maintenant, c'est différent.

(12:36 - 13:13)

D'accord ? Quand est-ce qu'on s'intéresse à la douleur ? Quand on a compression du nerf parfois. Est-ce que c'est ça ? A quel point ? C'est plutôt pour voir l'étiologie. Est-ce que c'est mécanique ? C'est dégénératif.

(13:14 - 13:22)

C'est lié à l'arthrose. Est-ce que vous entendez l'arthrose ? Tout ça, c'est mécanique. Lié à la dégénérescence.

(13:22 - 13:29)

La mécanique, c'est-à-dire le disque, c'est-à-dire le cartilage. Tout ça, c'est mécanique. Il n'y a pas de feu.

(13:31 - 13:58)

Mais, à l'opposé, je peux avoir une myoplasie, des métastases. Il peut y avoir une infection, ce qu'on appelle la spondylite ou la spondylodiscite. D'accord ? Le germe qui a migré vers, on va dire, une infection au niveau de la vertèbre, du corps du vertébral qui est passé le disque.

(13:59 - 14:14)

D'accord ? Il peut y avoir une atteinte ou un baptême. C'est pourquoi les caractéristiques de la douleur sont très importantes à faire soigner. La durée, les mêmes caractéristiques.

(14:14 - 14:24)

La durée, pour dire ? Règle chronique. Délai ? Trois mois. Siège.

(14:25 - 14:40)

C'est très important, le siège. Vous recevez une patiente qui a mal au niveau du rachis lombaire. Est-ce que c'est la même chose que chez une patiente qui a mal au niveau du rachis ? Vous voulez que tout le long du rachis fait mal.

(14:40 - 15:01)

Il a mal ici, il a mal ici. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est devant une atteinte segmentaire, ça veut dire intéressant, la douleur intéresse un seul segment, ou bien c'est une atteinte qui a intérêt le rachis. Dans sa globalité, et on parle de rachis agile global.

(15:02 - 15:13)

L'intensité. Toujours l'intensité, par les échelles qu'on a dévues. Voilà, hyper agile, wash modéré, wash faible.

(15:14 - 15:46)

Le rythme. Mécanique, inflammatoire ? Mécanique ? Après ? Après l'effort ? Verrouillage matinal ? Infirmière à 30 minutes ? Le repos ? Il n'y a plus mal ? D'accord. Et puis ? Pas de réveil nocturne, sauf ? Et l'inflammatoire ? Ici, le rachis, c'est très important de voir les facteurs.

(15:46 - 16:03)

Les facteurs déclenchants. C'est ce qu'on appelle les facteurs soit qui vont aggraver, soit qui vont déclencher la boule. Supposons qu'un ouvrier, l'Irois, à la suite du port de charge l'autre, il va se trouver coincé.

(16:04 - 16:11)

C'est ce qu'on appelle un embadou. Il ne peut plus faire l'expansion. Ça fait qu'il est bloqué.

(16:12 - 16:35)

Il ne peut plus faire quoi ? Ça, c'est le rachis. C'est l'attitude antagique. Il a peur que s'il va s'ajuster, il va y avoir une cassure C. C'est l'impression que le patient a. À la suite du port de charge, elle déclique et puis... D'accord ? Alors ça, c'est très important avec le facteur déclenchant.

(16:35 - 16:58)

Pourquoi ? Parce que le pauvre, c'est sans travail. Et puis, un seul épisode, il peut être le seul épisode qu'il va avoir quand il peut être le début d'une longue histoire de l'embadgie. D'accord ? C'est toujours... Il faut chercher s'il y a un facteur déclenchant.

(16:59 - 17:16)

Finalement, les embadgies, si on ne trouve rien à traiter, s'il y a des petits signes d'arthrose, il n'y a pas de traitement curatif. Il n'y a que le traitement symptomatique qui passe par l'éviction. Il faut éviter tout facteur déclenchant.

(17:17 - 17:28)

Vous voyez ? C'est pourquoi il faut insister sur les facteurs déclenchants. Le terrain, la progression. D'accord ? Et il y a deux types de douleurs.

(17:29 - 17:47)

Il y a la douleur du racisme liée à la racine motrice qui passe en postérieure. C'est pourquoi je peux avoir la participation de la douleur du racisme. Et il y a la sensitive qui va être responsable de ce que j'appelle la douleur radiculaire.

(17:48 - 18:23)

Douleur radiculaire va nous donner une douleur neuropathique. D'accord ? Alors, finalement, le patient peut avoir un syndrome rachidien lié à la douleur et à la mobilité qui peut être limitée, ce qu'on appelle la raideur, et le syndrome radiculaire. La douleur neuropathique, ce qu'on a dit hier, on en a parlé, qui peut être douloureuse.

(18:24 - 18:26)

J'ai écrit ça ici. C'est Bhajji. C'est la douleur.

(18:26 - 18:39)

C'est la douleur. C'est très douloureux. Alors, là, Bhajji, arrachement d'un mort, c'est très fort comme description.

(18:40 - 18:59)

Imaginez le sentiment qu'un patient peut être très douloureux quand il peut être ressenti comme des brûlures. Entendez ça autour de vous. Essayez de l'écouter, les gens.

(18:59 - 19:11)

D'accord ? Quand il peut être ressenti comme des éclairs. C'est les éclairs. D'accord ? Ils peuvent être spontanés ou provoqués.

(19:12 - 19:23)

Les fourmillements. Quand vous... Vous avez le sentiment de fourmillement. C'est très désagréable.

(19:24 - 19:33)

Tout le monde, je pense, a eu ce sentiment un jour. D'accord ? Vous oubliez les jambes. Vous oubliez les jambes qui sont là.

(19:33 - 19:47)

Et à un moment, vous vous demandez quand ça va se passer. Parce que c'est très désagréable. D'accord ? Si vous tapez dans l'écran, ça, c'est l'électricité.

(19:48 - 19:56)

Imaginez, ça c'est juste un point bref. Imaginez le patient qui le sent. Le courant qui passe.

(19:56 - 20:04)

Qui passe et qui ne vient plus revenir. D'accord ? Bien. On passe au racisme.

(20:10 - 20:33)

Qu'est-ce que ça prend au racisme ? Toujours l'inspection. Notre patient qui a pris une charge lourde et quand il est arrivé à se mettre devant, il va chercher la position la moins douloureuse. C'est ce qu'on appelle une attitude antalgique.

(20:34 - 20:41)

Ça veut dire que par lui-même, j'y aide, parce qu'il sait quand il va se redresser. Il a déjà essayé. C'est très mal.

(20:42 - 21:03)

Alors là, il va chercher une petite attitude antalgique. Je peux si je maintiens mon racisme. C'est très mal.

Je vais me faire une petite réflexion, comme ça. Bien. Découvrez.

(21:05 - 21:23)

Ça, c'est juste pour vous dire les différentes déformations qu'on peut avoir. C'est ce qu'on appelle la scoliose. La scoliose, c'est une déviation du racisme dans l'axe frontal par rapport à une rotation anormale de quelques vertèbres.

(21:23 - 21:40)

Quelques vertèbres. Alors là, c'est indifférent avec l'attitude scoliotique. L'attitude scoliotique, c'est juste une personne qui ne tient pas bien les postures.

(21:43 - 22:48)

Ils vont finir par développer un état courbeur, parce que c'est très difficile de se redresser après. Mais ce n'est pas pathologique. Il faut juste une bonne hygiène de vie.

D'accord ? Alors, comment faire la part ? En demandant au patient de se pencher en avant,

qu'est-ce que vous remarquez ? Celle qui a l'attitude, elle se corrige, il n'y a pas de problème. Celle qui a les vertèbres rosées, regardez, c'est ce qu'on appelle la gibosité. Ça, c'est juste un petit exemple.

Voici quelques modèles Le syphose dorsale, c'est l'accentuation de la syphose dorsale à tel point que chez cette patiente, elle va avoir mal à voir l'horizon. D'accord ? Généralement, c'est ce qu'on voit chez les vieilles personnes, par les fractures dorsales liées à l'ostéoporose. L'ostéoporose, il y a une échelle.

(22:50 - 23:02)

Alors, voici quelques déformations. Regardez cette patiente. Il a complètement perdu toutes les courbures.

(23:02 - 23:09)

C'est ce qu'on appelle un rachis en blanc. C'est une rectitude. Rectitude du rachis.

(23:09 - 23:22)

Il n'y a plus de l'ordre, il n'y a plus de syphose. Cette patiente, il a un dos qui est arché. C'est lié à des rhumatismes inflammatoires.

(23:24 - 23:37)

D'accord ? La palpation. On fait une palpation le long de la colonne sur les épineuses. Entre les épineuses et en latéral des épineuses.

(23:38 - 23:48)

En latéral, c'est ce qu'on appelle le signe de la sonnette. Quand j'appuie en latéral, le patient va se sentir. Je vais reproduire sa douleur.

(23:49 - 24:00)

S'il ressentait le courant, l'hystéralose et il sursaute. C'est le signe de la sonnette. Et je vais commencer ma mobilisation.

(24:01 - 24:15)

La mobilisation, là aussi, je vais chercher. C'est très important. Est-ce que le patient a une raideur segmentaire ? La limitation de la mobilité intéresse à un segment du racisme.

(24:15 - 24:38)

On a tout le racisme. Et on parle d'une raideur globale. La mobilité au niveau du racisme cervical.

Le racisme cervical, le racisme envers, sont les plus mobiles. Ils permettent la mobilisation dans les trois points. Alors qu'est-ce que je demande au patient ? De garder la position neutre.

(24:38 - 24:49)

D'accord ? Je vais lui demander de faire mon flexion. Et je vais voir, je vais compter. Normalement, la distance montant celle-là est égal à zéro.

(24:50 - 25:05)

D'accord ? L'extension, celle-là, normalement, en fait, ça nous dit que c'est cette majeure. Ça, c'est au non-terrieur. Je reviens toujours là dans le mouvement tourné.

(25:05 - 25:14)

D'accord ? Dans le référent. Je reviens. Je vais lui demander de faire une rotation qui garde les épaules dégagées.

(25:14 - 25:24)

Je vais lui demander de faire une rotation. Je vais mesurer la distance entre le montant et la promenade. Les deux côtés.

(25:24 - 25:39)

D'accord ? Il revient toujours. Il fait ça. S'il a mal, il ne va pas le faire.

Il a mal. A ou là. Une différence des deux côtés supérieure à deux centimètres, il y a un problème.

(25:40 - 25:57)

A gauche, il y a l'inclinaison, l'extension et la rotation. Il y a les inclinaisons. L'inclinaison, c'est que j'incline ma tête et je vais mesurer la distance entre le trabut d'abord de l'oreille et la promenade.

(25:58 - 26:02)

Pareil. Je reviens et je fais ça. C'est bon ? Réussi syndicalement.

(26:03 - 26:13)

Non-terrieur, rotation latérale. Rachis dorsal. Le rachis dorsal est le moins mobile.

(26:14 - 26:20)

Il ne bouge pas. Quand est-ce qu'il bouge ? La respiration. Très bien.

(26:20 - 26:31)

C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle l'inclinaison thoracique. Je prends le mètre devant. On regarde les mains lentes.

(26:32 - 26:42)

Au passage, je fais l'inclinaison profonde. Je vais mesurer la première mesure. Je vais lui demander de faire une expiration.

(26:44 - 26:55)

Je vois la différence. L'inclinaison thoracique normale congrue plus ou égale à 6 centimètres. C'est compris ? Le mètre devant.

(26:55 - 27:18)

On regarde les mains lentes. Inspiration, première mesure. Profonde.

Expiration, deuxième mesure. Et j'ai la différence qui doit être supérieure ou égale à 6 centimètres. Le rachis lombaire, comme le rachis cervical, il permet d'éliminer dans les 3 sens.

(27:18 - 27:25)

La flexion, l'extension. Je reviens. Je fais l'inclinaison.

(27:26 - 27:30)

C'est le rachis qui doit. Il ne doit pas bouger. Les membres tiennent.

(27:32 - 27:44)

Pour les rotations, je fais ça. Il doit tourner les deux côtés. Pour voir s'il y a une hauteur, je vais mesurer.

(27:45 - 27:59)

Quand je lui demande de se pencher en avant, il doit maintenir les membres inférieurs tout tendus. Il ne doit pas fléchir les genoux. Il se penche.

(28:00 - 28:14)

Je vais mesurer la distance entre ses mains et le sol. Et je vais mesurer l'indice de chauffe. Quand il est debout, je vais maintenir les crêtes.

(28:15 - 28:25)

Et je vais voir si je trace une ligne qui passe par les épineux. Voilà mon premier point. Voici les crêtes.

(28:25 - 28:35)

Le point sur l'épineuse correspond à mon premier point. Je vais mesurer en haut 10 cm. Je trace mon deuxième point.

(28:36 - 28:51)

Je vais demander au patient de se pencher en avant en tenant les genoux bien tendus. Normalement, ça va s'élargir. Et je dois voir une valeur supérieure ou égale à 4 cm.

(28:51 - 29:31)

Si maintenant le patient n'arrive pas à croire qu'il a 2 cm, ça veut dire qu'il a un problème au niveau du rachis. C'est bon ? C'est un drame radiculaire. Je cherche à reproduire la douleur.

D'accord ? Comment ? On en a deux. Si je suis dans la lombosciatique, j'utilise, je teste ce qu'on appelle le laser. Le patient en équilibre dorsal, je tiens de façon passive son membre inférieur bien tendu et je vais faire une élévation.

(29:33 - 29:42)

À un moment donné, il va sentir la douleur. Ça veut dire que le laser est positif. D'accord ? Le lary, c'est pour l'écruralgie.

(29:43 - 29:59)

Alors là aussi, l'écrural c'est antérieur. C'est pourquoi je le fais sur un patient qui est en décubitus ventral. Et je fais une élévation de telle poids, de telle sorte que je vais faire un étirement sur le nerf.

(29:59 - 30:14)

On n'est pas obligé de retenir les noms Ni, Te, La. C'est juste pour voir de l'examen en totalité. Et finalement, on est dans un terrain de nerf.

(30:14 - 31:03)

Vous terminez par un examen neurologique très détaillé, très minutieux à la recherche d'un problème de sensibilité, d'une perte du micro, d'un problème musculaire, d'un déficit musculaire. Il faut chercher les réflexes aux théopendineux et bien sûr ne pas oublier de demander le patient est-ce qu'il a des fuites urinaires qui correspondent, qui sont concomitantes avec la douleur. Ça

veut dire qu'il y a un problème sur le sphinctre.

Ce sont des signes de gravité. Si maintenant le patient avait un transit normal et tout d'un coup il commence à avoir une constipation. Je n'ai jamais eu de constipation.

(31:03 - 31:14)

Les troubles sphinctériens, ils n'arrivent plus à retenir les urines. Ils n'arrivent plus à retenir les seines. Ça veut dire qu'il faut sonner l'alarme.

(31:19 - 31:41)

Alors, là, voici les territoires et les métamètres. Au niveau du racisme, la C4, C5, au niveau du moignon de l'hépatite. Le patient sent la douleur ici, ça ne descend pas.

(31:41 - 32:01)

C3, C4, superficielle, C5, au moignon de l'épaule. C6, il est, suivez-moi, C6, il est extérieur. Le patient va vous montrer sa douleur.

(32:02 - 32:21)

Il va vous montrer sa douleur qu'il peut décrire avec le doigt. Il se termine sur le pouce. C6, C4, superficielle, C5, au moignon de l'épaule, C6, extérieur, pouce, moitié, il peut aller à la moitié de la tête.

(32:21 - 32:35)

C7, extérieur, C6, vers l'écran, il va sentir l'écran, vers le majeur. C8, il est interne. Bien, répétez.

(32:36 - 33:15)

C4, l'épaule superficielle, C7, C5, au moignon, c'est pourquoi, si vous vous rappelez tout à l'heure la douleur de l'épaule, est-ce qu'il ne faut pas éliminer, il ne faut pas oublier l'exemple numéro 6. Il peut correspondre à C5. C6, extérieur, le patient va se voir ici, pour lui, le pouce, la moitié de l'index, C7, extérieur, vers l'écran, C7, C8. Très, très bien, vous avez réussi.

(33:17 - 33:27)

La scientifique, la scientifique électroragique. Alors, scientifique, il y a S1, et M5. M5, c'est celle qui est au mot.

(33:28 - 34:06)

Et les postérieurs, au niveau de leur fesse, postérieurs, elle devient postéro-externe, au niveau de ma cuisse, pour devenir entéro-externe, au niveau de la jambe, et se termine sur le gros orteil.

L5, postérieurs, au niveau de la cuisse, postéro-externe, portant la fesse, postéro-externe, au niveau de la cuisse, entéro-externe, au niveau de la jambe, et se termine sur le gros orteil. Bien, S1, elle est postérieure.

(34:06 - 34:58)

S1, elle est postérieure au niveau de la fesse, de la cuisse, elle devient extérieure au niveau de la jambe, pour se terminer sur le bord interne, le bord plutôt externe du pied. C'est bon ? Répétez, S1, postérieure, fesse, cuisse, elle devient postéro-extérieure, externe au niveau de la jambe, et se termine sur le bord, le bord externe du pied. L5, postérieure au niveau de la fesse, postéro-externe, au niveau de la cuisse, postéro-externe au niveau de la jambe, le gros orteil.

(34:59 - 35:42)

L5, c'est le gros orteil. S1, elle est postérieure. Les cruragies sont antérieures, voici la L3, elle peut être, si on a un embout cruragique, il peut s'accompagner d'une douleur lombaire, et il est ressenti au niveau de la fesse, antéro-interne, c'est des douleurs qui brûlent, L4, elle descend un peu plus bas, au niveau de la jambe, elle est plus externe que la L3, mais c'est toujours dans la partie antérieure de la cuisse.

(35:43 - 37:13)

C'est bon ? C'est très important, ça c'est très important parfois, d'accord ? Bien, dernière question, bientôt. Je vous ai demandé tout à l'heure pourquoi insister sur l'état précis de la douleur, pour finalement différencier entre les différentes études. Il y a deux grands types, de rachialgie, ou de radiculagie, d'accord ? Il y a tout ce qu'on appelle rachialgie ou radiculagie commune, c'est en rapport avec tout ce qui est mécanique, dégénératif, d'accord ? A l'opposé, il y a ce qu'on appelle symptomatique, ou secondaire.

Si je vous dis rachialgie, radiculagie, secondaire, on est bel et bien dans le symptomatique. Alors, quand on a une rachialgie ou radiculagie commune, c'est le cas de notre ouvrier qui a eu le temps de faire la charge de toute la douleur. C'est mécanique, il peut, quand il va à l'église de prêtre, des ouvriers de part et d'autre, il peut dormir la douleur, et finalement il est mécanique même si il est intense.

(37:14 - 37:52)

On va aller à l'IRN, qu'est-ce qu'on va trouver ? Soit qu'il a une hernie, soit qu'il a une luxation ligamentaire, soit d'arthrose ou autre. C'est ce qu'on appelle les étiologies, les causes de rachialgie mécanique. La douleur, il est mécanique, et généralement, quand vous allez faire un inférendatoire, c'est un seul territoire, il a une scientifique, il a une aide, ça sera d'un lien de 5 milles, gros orteils ou de 5 orteils.

(37:53 - 38:13)

D'accord ? C'est un seul membre, une seule racine. L'impulsivité, la impulsivité, il est presque pathogonomique d'une hernie distincte. C'est le patient qui a la reproduction de la douleur quand il étrenue.

(38:14 - 38:26)

Quand il tousse, il sent le courant descendre. La défécation, il a très mal. Très mal, ça reproduit.

(38:27 - 38:46)

Ça, c'est ce qu'on appelle l'impulsivité. En fait, c'est l'accentuation de la douleur à la toux, à la défécation, à tout effort qui peut déclencher la douleur. Quand elle est positive, ça, c'est une hernie distincte, juste à preuve du cancer.

(38:46 - 39:02)

D'accord ? Généralement, on est dans tout ce qui est mécanique. On ne doit pas avoir de fièvre. Pourquoi le racisme entier va avoir un problème au normal ? Le patient a une raideur segmentaire.

(39:03 - 39:14)

Il n'y a pas d'aterrassant de l'état général. L'aterrassant de l'état général, c'est les trois A. Astéline, amélioration, anorexie. Très bien.

(39:15 - 39:38)

Et les causes les plus fréquentes, c'est l'arthrose. L'hernie distincte, un canal lombaire étroit. On va la mettre ici.

D'accord ? Ça, c'est tout ce qui est mécanique. Alors, il y a le problème symptomatique ou subordinaire. La douleur, elle est inflammatoire.

(39:39 - 40:25)

Je peux trouver la fièvre. Je peux trouver l'aterrassant de l'état général. Si j'ai la fièvre à tension, est-ce que le patient n'est pas en train de faire une spondylodiscite tuberculeuse liée à la tuberculose, par exemple ? C'est juste par le seul réflexe de demander à la fièvre à tension, est-ce qu'elle n'est pas en train de faire une spondylodiscite ? Alors là, quand c'est inflammatoire, je peux trouver plusieurs.

Le patient qui a mal au niveau du rachis, s'il a mal au niveau du rachis envers, évaluer l'hygiène, l'anesthésique. C'est plusieurs racines à la fois et il peut avoir tout le rachis qui est limité. D'accord

? Là, il faut bien sûr chercher l'infection.

(40:26 - 40:48)

Est-ce que le patient n'est pas en train de faire un rhumatisme inflammatoire ? Ou bien, est-ce que ce n'est pas néoplasique ? Est-ce que c'est compris ? Je vous demande de bien réviser, comme ça, les QCL un déours par émissions. D'accord ? Et on revient sur plusieurs choses.